

Trastornos Psicóticos: Esquizofrenia

Introducción a los Trastornos Psicóticos

Los trastornos psicóticos representan una de las áreas más graves de la psiquiatría. Su característica patognomónica es la **pérdida del juicio de realidad**: el individuo es incapaz de diferenciar los contenidos de su mente (fantasías, pensamientos, temores) de los estímulos del mundo exterior.

- Un diagnóstico precoz y un manejo adecuado son determinantes para el pronóstico funcional del paciente. Dentro de este espectro encontramos:
- **Esquizofrenia**: El trastorno más frecuente y emblemático.
- **Trastorno Delirante Crónico**: Caracterizado por ideas delirantes fijas sin otros síntomas de esquizofrenia.
- **Trastorno Esquizoafectivo**: Mezcla síntomas de la esfera psicótica con trastornos del ánimo (**Trastorno Bipolar o Depresión**).
- **Psicosis Reactiva**: Desencadenada por un evento estresante agudo.
- **Psicosis Posparto**: Cuadro grave que requiere detección inmediata tras el parto.
- **Episodio Psicótico Breve**: De corta duración y resolución completa.

Farmacoterapia: Antipsicóticos

El tratamiento farmacológico se basa en los antipsicóticos (neurolepticos), divididos en dos grandes grupos:

1. Antipsicóticos Típicos (Primera Generación)

Conocidos como "tranquilizantes mayores", actúan principalmente bloqueando receptores dopaminérgicos D2. - **Ejemplos**: **Haloperidol** (clásico), Clorpromazina, Tioridazina. - **Uso**: Preferencia en cuadros **agudos** y situaciones de **agitación psicomotora** (ej. "dardos" tranquilizantes). - **Efectos Adversos**: Elevado riesgo de síntomas extrapiramidales (SEP).

2. Antipsicóticos Atípicos (Segunda Generación)

Actúan sobre receptores de dopamina y serotonina. Son los llamados "tranquilizantes menores" (aunque este término es menos preciso clínicamente). - **Ejemplos**: **Risperidona**, **Quetiapina**, **Olanzapina**, **Clozapina**. - **Uso**: Elección para el **manejo crónico**. Tienen mejor efecto sobre los **síntomas negativos** de la esquizofrenia. - **Efectos Adversos**: Menor frecuencia de SEP, pero mayor riesgo de síndrome metabólico.

TABLA 7.16.1: FÁRMACO VS TIPO		
FÁRMACO	TIPO	NOTA CLÍNICA
Haloperidol	Típico	Gold standard para agitación aguda (IM).
Clozapina	Atípico	Uso en esquizofrenia refractaria. Requiere hemograma.
Risperidona	Atípico	Muy usado en mantenimiento crónico.
Olanzapina	Atípico	Perfil sedativo, útil en manía y psicosis.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **Clozapina** tiene un riesgo bajo de síntomas extrapiramidales, pero puede producir **agranulocitosis (neutropenia grave)**. Es obligatorio realizar controles de hemograma periódicos para monitorizar el recuento de glóbulos blancos y prevenir infecciones graves.

Esquizofrenia: Clínica y Etiología

La esquizofrenia tiene un fuerte componente genético (herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta). El debut suele

ocurrir en la adolescencia tardía o adultez joven (entre los 15 y 30 años).

NOTA CLÍNICA

El consumo de **cannabis** (marihuana) en sujetos con predisposición genética aumenta significativamente el riesgo de gatillar el primer brote psicótico y desarrollar esquizofrenia.

Síntomas de la Esquizofrenia

- Se dividen en dos esferas principales:
- **Síntomas Negativos (Deficitarios o Primarios)**:
 - Son los más característicos y los que generan mayor discapacidad a largo plazo. Se suelen recordar con la letra "A":
 - - **Apatía**: Falta de interés.
 - - **Aplanamiento afectivo**: Escasa reactividad emocional.
 - - **Abulia**: Falta de voluntad o iniciativa.
 - - **Alogia**: Empobrecimiento del pensamiento y lenguaje.
 - - Disfunción ejecutiva (dificultad para planificar o crear).
 - **Síntomas Positivos (Productivos o Secundarios)**:
 - Son los más llamativos y definen el "brote":
 - - **Delirios**: Ideas fijas, falsas, irreductibles a la lógica y fuera del contexto cultural.
 - - **Alucinaciones**: Percepciones sin objeto. En la esquizofrenia son típicamente **auditivas personificadas** (voces que insultan, comentan actos o dan órdenes).
 - - **Alteraciones del comportamiento**: Conductas bizarras o desorganizadas.

Tipos de Esquizofrenia

TABLA 7.16.2: TIPO VS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
TIPO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Paranoide	La más clásica. Predominan delirios de persecución y alucinaciones auditivas.
Simple	Solo presenta síntomas negativos desde el inicio. Sin brotes positivos claros. Difícil diagnóstico.
Residual	Persistencia de síntomas negativos tras la resolución de un brote positivo previo.
Catatónica	Predominan síntomas motores: flexibilidad cérea (el paciente mantiene posturas impuestas) o estupor catatónico.
Hebefrénica	También llamada Desorganizada . Delirio incoherente, afecto inapropiado y peor pronóstico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **flexibilidad cérea** es un signo clásico de la esquizofrenia catatónica: al mover una extremidad del paciente, esta queda fija en la posición final como si fuera de cera o una estatua.

Algoritmo de Tratamiento

- El manejo debe ser **multidisciplinario**, involucrando a psiquiatras, médicos generales, terapeutas ocupacionales y la red de apoyo familiar.
- **Primera Línea**: Antipsicótico atípico vía oral (ej. Risperidona u Olanzapina).
 - **Segunda Línea**: Si no hay respuesta, cambiar a otro antipsicótico (puede ser típico o atípico).
 - **Tercera Línea (Refractariedad)**: Si fallan dos esquemas previos (al menos uno atípico), se indica **Clozapina**.
 - **Paciente Agitado/Agresivo**: Manejo de urgencia con **Haloperidol 5 mg IM**.

- **Mala Adherencia:** Si el paciente no toma sus fármacos de forma sistemática, se utilizan **antipsicóticos de depósito** (inyectables mensuales como el Decanoato de Haloperidol o Modicate).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el manejo de la agitación psicótica aguda, es vital la contención física y farmacológica inmediata para proteger al paciente y al personal. El uso de Haloperidol IM es la norma.

Pronóstico en Esquizofrenia

El pronóstico es variable y depende de múltiples factores identificables en la historia clínica:

- **Buen Pronóstico:**
 - Inicio súbito o agudo.
 - Buena adaptación previa (paciente casado, con trabajo o profesión).
 - Presencia de factores desencadenantes claros.
 - Predominio de síntomas positivos.
- **Mal Pronóstico:**
 - Inicio insidioso o "lavado" (lento y progresivo).
 - Predominio de **síntomas negativos**.
 - Tipos catatónico o hebefrénico.
 - Desajuste social previo.
 - **Demora en el inicio del tratamiento** (el tiempo de psicosis no tratada daña la personalidad y la red de apoyo).

NOTA CLÍNICA

El objetivo terapéutico es la funcionalidad. Un paciente con esquizofrenia con buen apoyo familiar y adherencia farmacológica puede ser 100% funcional en la sociedad.

Antipsicóticos Trastorno Delirante Urgencias Psiquiátricas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 24 años es traído por sus padres porque lleva 1 año cada vez más aislado, sin motivación para trabajar ni estudiar, con aplanamiento afectivo y sin amigos. No hay alucinaciones ni delirios. Tiene un hermano con esquizofrenia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Psicóticos: Esquizofrenia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síntomas negativos de esquizofrenia (primarios): apatía, aplanamiento afectivo, abulia. Son los más característicos y más discapacitantes.
- Las alucinaciones en esquizofrenia son típicamente auditivas y personificadas (voces que ordenan, comentan o insultan).
- Agitación psicomotora por psicosis: haloperidol (aldol) 5 mg IM.
- Antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina, quetiapina) son la primera línea crónica por menos efectos extrapiramidales.
- Clozapina: de elección en esquizofrenia refractaria (falla a 2 antipsicóticos); riesgo de agranulocitosis (control de neutrófilos).
- Cannabis en predisposición genética: duplica o triplica el riesgo de desarrollar esquizofrenia.
- Buen pronóstico: inicio agudo, buen funcionamiento previo, muchos síntomas positivos. Mal pronóstico: inicio insidioso, esquizofrenia catatónica o desorganizada.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS PSICÓTICOS: ESQUIZOFRENIA)**PREGUNTA 1**

Hombre de 24 años es traído por sus padres porque lleva 1 año cada vez más aislado, sin motivación para trabajar ni estudiar, con aplanamiento afectivo y sin amigos. No hay alucinaciones ni delirios. Tiene un hermano con esquizofrenia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Depresión mayor; ISRS
- B)** Trastorno de personalidad esquizoide; psicoterapia
- C)** Esquizofrenia simple; antipsicótico atípico + abordaje multidisciplinario
- D)** Consumo de cannabis; intervención en adicciones
- E)** TOC grave; ISRS

PREGUNTA 2

Mujer de 22 años sin antecedentes es traída a urgencias muy agitada. Su familia refiere que lleva 2 semanas escuchando "voces que le ordenan que se lastime" y que ve personas que quieren hacerle daño. Está muy agresiva y amenaza con golpear al médico. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Olanzapina oral 5 mg y observación
- B)** Haloperidol 5 mg IM para contención farmacológica
- C)** Litio oral por sospecha de trastorno bipolar en fase maníaca
- D)** Benzodiacepinas IV para sedación
- E)** Intentar contención verbal antes de cualquier medicación

PREGUNTA 3

Paciente de 30 años con esquizofrenia está en tratamiento con risperidona. A los 6 meses sigue con alucinaciones y delirios. Se verifica que toma los medicamentos pero sin respuesta. Se cambia a olanzapina sin mejoría significativa. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Agregar un segundo antipsicótico (risperidona + olanzapina)
- B)** Clozapina, con control periódico de hemograma por riesgo de agranulocitosis
- C)** Antidepresivo ISRS por sospecha de depresión subyacente
- D)** Hospitalización indefinida en institución psiquiátrica
- E)** Antipsicótico de depósito (modecate) por mala adherencia

RESUMEN: TRASTORNOS PSICÓTICOS: ESQUIZOFRENIA

La esquizofrenia es la principal patología psicótica, de causa genética con penetrancia incompleta. Debuta típicamente en la adolescencia tardía o en los 20 años. El consumo de cannabis en personas con predisposición genética puede duplicar o triplicar el riesgo de desarrollarla. La clínica se organiza en síntomas negativos (primarios/deficitarios: apatía, aplanamiento afectivo, abulia, alteraciones cognitivas) y síntomas positivos (secundarios/productivos: delirios, alucinaciones, alteraciones graves del comportamiento). Los síntomas negativos son los más característicos de la esquizofrenia y los que generan mayor disfunción social y laboral, aunque son difíciles de detectar. Los síntomas positivos son los más vistosos y los que definen los brotes psicóticos. Las alucinaciones en la esquizofrenia son típicamente auditivas y personificadas (voces que ordenan, comentan o insultan). Existen varios tipos de esquizofrenia: paranoide (la más frecuente, con delirios paranoides y alucinaciones), simple (solo síntomas negativos, sin síntomas positivos), residual (solo síntomas negativos porque está tratada), catatónica (síntomas motores: rigidez cérea, estupor catatónico) y ebifrénica o desorganizada (delirio raro e incomprensible, mal pronóstico). El tratamiento es multidisciplinario con antipsicóticos atípicos como primera línea (risperidona, quetiapina, olanzapina) por tener menos efectos adversos extrapiramidales. Tras el fracaso de dos antipsicóticos se indica clozapina (de elección en esquizofrenia refractaria) con control de neutrófilos por riesgo de agranulocitosis. En agitación aguda: haloperidol (aldol) 5 mg IM. Los antipsicóticos de depósito (modecate) se usan cuando la adherencia es imposible de garantizar. Los factores de buen pronóstico son: buen funcionamiento previo (casado, profesional), inicio agudo, muchos síntomas positivos y pocos negativos. Los de mal pronóstico son: muchos síntomas negativos, inicio insidioso, esquizofrenia catatónica o desorganizada, y demora en el tratamiento.